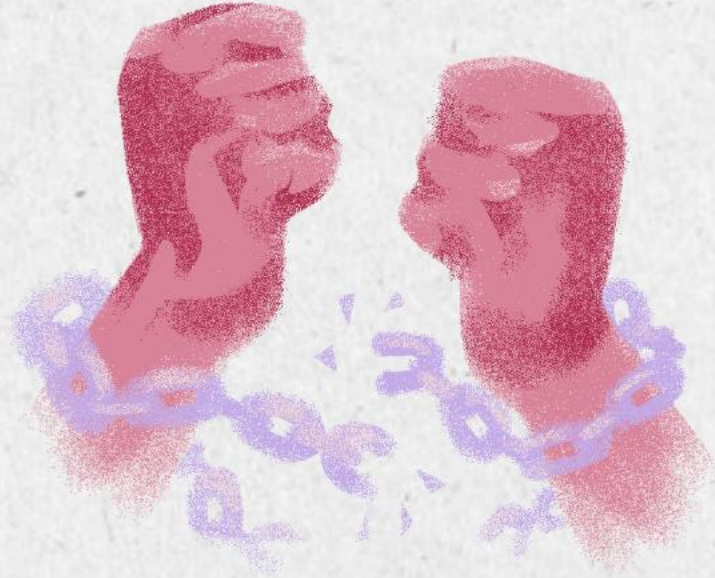




TRASTORNOS ADICTIVOS Y RELACIONADOS CON SUSTANCIA

**Profesora:
Dra. Aelen López**

**Asignatura:
Psicopatología I Niñez y
Adolescencia**

**Por:
Ricardo Padilla
Genesis Montero**

FRASE, PENSAMIENTO U REFLEXIÓN

**LA ADICCIÓN ES UNA
ENFERMEDAD QUE
REQUIERE UN ENFOQUE
MÉDICO, NO UN JUICIO
MORAL.**

POR: VINCENT DOLE.



QUE SON LOS TRASTORNOS ADICTIVOS Y RELACIONADOS CON SUSTANCIA

El trastorno por consumo de sustancias (TCS) es un padecimiento que se define como el uso problemático de una sustancia como alcohol, drogas o medicamentos recetados. El individuo consume intensamente ya a pesar de las consecuencias dañinas. Esto afecta su capacidad de funcionar día a día.



DROGAS CAUSANTES DE TRASTORNOS ADICTIVOS POR CONSUMO DE SUSTANCIA SEGÚN EL DSM-5-TR

- SON 10 LAS DROGAS RELACIONADAS CON LOS TRASTORNOS ADICTIVOS Y RELACIONADOS CON SUSTANCIAS, LAS CUALE SON:
- ALCOHOL
- CAFEÍNA
- CANABIS
- ALUCINÓGENOS
- INHALANTES
- OPIOIDES
- SEDANTES
- HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS
- ESTIMULANTES (INCLUIDAS SUSTANCIAS DE TIPO ANFETAMÍNICO, COCAÍNA Y OTROS ESTIMULANTES)
- TABACO



TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA CAFEÍNA

- Intoxicación por cafeína
- Abstinencia de cafeína
- Trastornos mentales inducidos por la cafeína
- Trastorno relacionado con la cafeína no especificado



TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL CANNABIS

- Trastorno por consumo de cannabis
- Intoxicación por Cannabis
- Abstinencia de cannabis
- Trastornos mentales inducidos por el cannabis
- Trastorno no especificado relacionado con el cannabis



TRASTORNOS RELACIONADOS CON ALUCINÓGENOS

- Trastorno por consumo de fenciclidina
- Otro trastorno por consumo de alucinógenos
- Intoxicación por fenciclidina
- Otra intoxicación por alucinógenos
- Trastorno de percepción persistente por alucinógenos
- Trastornos mentales inducidos por fenciclidina
- Trastornos mentales inducidos por alucinógenos
- Trastorno no especificado relacionado con fenciclidina
- Trastorno no especificado relacionado con alucinógenos



TRASTORNOS RELACIONADOS CON INHALANTES

- Trastorno por uso de inhalantes
- Intoxicación por inhalantes
- Trastornos mentales inducidos por inhalantes
- Trastorno no especificado relacionado con inhalantes



TRASTORNOS RELACIONADOS CON OPIOIDES

- Trastorno por uso de opioides
- Intoxicación por opioides
- Abstinencia de opioides
- Trastornos mentales inducidos por opioides
- Trastorno no especificado relacionado con opioides



TRASTORNOS RELACIONADO CON SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS

- Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
- Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
- Abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
- Trastornos mentales inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
- Trastorno no especificado relacionado con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos



TRASTORNOS RELACIONADOS CON ESTIMULANTES

- Trastorno por uso de estimulantes
- Intoxicación por estimulantes
- Retiro de estimulantes
- Trastornos mentales inducidos por estimulantes
- Trastorno no especificado relacionado con estimulantes



TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TABACO

Criterios Diagnósticos (2 o más síntomas en 12 meses):

1. Consumo en mayor cantidad o más tiempo del previsto.
2. Deseo persistente o intentos fallidos de dejar o reducir.
3. Mucho tiempo invertido en obtener o consumir.
4. Craving (ansias intensas).
5. Incumplimiento de obligaciones.
6. Uso continuado pese a problemas sociales/interpersonales.
7. Reducción o abandono de actividades importantes.
8. Uso en situaciones de riesgo.
9. Uso pese a problemas físicos o psicológicos.
10. Tolerancia.
11. Abstinencia.



CRITERIO DIAGNOSTICOS

Esta clasificación diagnostica los trastornos tendrán una forma muy similar de diagnosticarse que sus pares de otros trastornos



TRASTORNOS NO RELACIONADOS CON SUSTANCIAS



- Trastorno del juego



TRASTORNO RELACIONADO CON EL TABACO NO ESPECIFICADO

Patrón persistente y recurrente de conducta de juego problemático que provoca deterioro o malestar clínicamente significativo.

Criterios diagnósticos (4 o más en 12 meses):

1. Necesidad de apostar cantidades crecientes de dinero (tolerancia).
2. Inquietud o irritabilidad al intentar reducir o dejar de jugar (abstinencia conductual).
3. Esfuerzos repetidos e infructuosos para controlar, reducir o abandonar el juego.
4. Preocupación frecuente por el juego (revivir experiencias, planificar, pensar en conseguir dinero).
5. Juega cuando se siente angustiado (ansiedad, culpa, depresión, etc.).
6. Después de perder dinero, vuelve para "recuperar" lo perdido (perseguir pérdidas).
7. Miente para ocultar el grado de implicación en el juego.
8. Ha puesto en riesgo o perdido relaciones, trabajo u oportunidades importantes.
9. Depende de otros para aliviar situaciones financieras causadas por el juego.

TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS, UNA CRECIENTE PREOCUPACIÓN DE SALUD PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas

Un nuevo análisis de la OPS revela una carga creciente y profunda de trastornos por consumo de drogas y sus consecuencias para la salud en la Región de las Américas.



**17.7 MILLONES
DE PERSONAS**

en las Américas viven con
trastornos por consumo de
drogas.

Equivale al **2,9%** de la población
de 15 a 64 años.



**≈78,000
MUERTES DIRECTAS**

cada año debido al consumo
de drogas.

Más del **75%** de estas muertes están
relacionadas con el consumo de opioides.



**145,515
MUERTES INDIRECTAS**

cada año asociadas al consumo
de drogas.

Esto incluye muertes por otras enfermedades,
lesiones y suicidio.

¿QUIÉNES SE VEN MÁS AFECTADOS?



Los hombres jóvenes (30 a 39 años)
representan la carga más alta de
trastornos por consumo de drogas.



La carga de enfermedad también es mayor en personas
en situación de vulnerabilidad, incluidas aquellas que
enfrentan pobreza, marginación y entornos de alto riesgo.

UNA TENDENCIA AL ALZA



La carga de trastornos por consumo de drogas
en la Región ha aumentado de manera
sostenida durante la última década.



Aumento promedio anual de
aproximadamente 5%
en la carga de enfermedad desde 2015.



Si no se toman medidas urgentes, se espera que
esta tendencia continúe en aumento en los
próximos años.

IMPACTO EN LA SALUD Y EL BIENESTAR



Los trastornos por consumo de drogas afectan
la salud física y mental, la calidad de vida y el
desarrollo social y económico.



También generan una carga significativa para
las familias, comunidades y sistemas de salud.



Abordar este desafío requiere enfoques integrales,
basados en evidencia, centrados en las personas
y respetuosos de los derechos humanos.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?



Fortalecer la prevención
basada en evidencia.



Ampliar el acceso a servicios
de tratamiento y atención
integral y de calidad.



Reducir el estigma y
promover la inclusión
social.



Mejorar los datos y el
monitoreo para orientar
políticas efectivas.



Invertir hoy en soluciones
salva vidas y construye
comunidades más saludables
y resilientes.



Referencia: Organización Panamericana de la Salud. (14 enero 2026). Trastornos por consumo de drogas,
una creciente preocupación de salud pública en las Américas. OPS Organización Panamericana de la Salud.



<https://www.paho.org/es/noticias/14-1-2026-trastornos-por-consumo-drogas-creciente-preocupacion-salud-publica-americas>

CONSUMO DE DROGAS EN PANAMÁ

INFORME CONAPRED PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS EN PANAMÁ Y SUS EVENTOS CONEXOS

1. CONSUMO DE SUSTANCIAS LÍCITAS



32.1%
ha fumado tabaco
alguna vez

6%
consumo actual
de tabaco

POR SEXO – CONSUMO ACTUAL DE TABACO

HOMBRES
10.4%

MUJERES
2.3%

Mayor consumo en hombres (10.4%) vs mujeres (2.3%).

2. MEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN



14,600
personas usaron
tranquilizantes sin receta



Mayor consumo en mujeres,
especialmente entre
45 y 65 años.

3. CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS



6.8%
ha consumido alguna
droga ilícita en su vida

1.2%
consumo en el
último año

POR SEXO – CONSUMO EN EL ÚLTIMO AÑO

HOMBRES
2.2%

MUJERES
0.3%

Mayor prevalencia en hombres (2.2%) vs mujeres (0.3%).

4. CANTIDAD ESTIMADA DE CONSUMIDORES



22,500
personas consumieron
drogas ilícitas en
el último año



5. EDAD DE MAYOR RIESGO



3.7%

mayor consumo entre
18 – 24 años

1.6%

adolescentes
12 – 17 años

Prevalencia de consumo
en el último año por edad



6. MARIHUANA (PRINCIPAL DROGA)



5.6%
la ha consumido
alguna vez

0.8%
consumo
reciente
(último año)

≈15,000
personas en
el último año

7. PERCEPCIÓN Y ACCESO



28.4%
considera fácil
conseguir
marihuana

13.6%
ha recibido
oferta de
marihuana

8. CONSUMO PROBLEMÁTICO



8,300
personas con consumo
abusivo o dependiente

IMPACTO

0.8%
hombres

0.1%
mujeres



Estas personas pueden
presentar problemas
graves en su salud,
relaciones, estudios,
trabajo y vida diaria.

CUADRO COMPARATIVO TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

DSM-5-TR

vs.

CIE-11

Similitudes y diferencias clave

ASPECTO	DSM-5-TR	CIE-11	SIMILITUDES / DIFERENCIAS CLAVE
 UBICACIÓN	Capítulo: Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos	Capítulo 06: Trastornos mentales, del comportamiento o del neurodesarrollo (bloque 6C4)	✓ Similitud: Ambos dentro de trastornos mentales
 NOMBRE DEL TRASTORNO PRINCIPAL	"Trastorno por consumo de sustancias"	"Trastornos debidos al uso de sustancias"	✓ Diferencia terminológica, pero mismo enfoque clínico
 ENFOQUE DIAGNÓSTICO	Modelo dimensional (leve, moderado, grave) según número de criterios	Enfoque categorial (episodios y patrones: uso nocivo, dependencia, intoxicación, abstinencia)	✓ Diferencia clave: DSM mide severidad; CIE clasifica tipos de presentación
 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS	11 criterios (control, deterioro social, riesgo, farmacológicos)	No usa lista única; describe características clínicas específicas por categoría	✓ DSM más estructurado; CIE más clínico-descriptivo
 SEVERIDAD	Leve (2-3), moderado (4-5), grave (6 o más)	No usa niveles de severidad explícitos	✓ Diferencia importante
 DEPENDENCIA	No usa el término como diagnóstico separado (se integra en el trastorno)	Sí distingue "síndrome de dependencia"	✓ Diferencia conceptual relevante
 USO NOCIVO / ABUSO	Elimina "abuso" (presente en DSM-IV)	Mantiene "episodio de uso nocivo" y "patrón de uso nocivo"	✓ CIE conserva categoría que DSM eliminó
 INTOXICACIÓN Y ABSTINENCIA	Subtipos o especificadores dentro del trastorno	Categorías independientes dentro de cada sustancia	✓ Similitud: Ambos reconocen estos estados
 CLASIFICACIÓN POR SUSTANCIA	Alcohol, cannabis, opioides, estimulantes, etc.	Igual, pero con codificación más detallada (6C40-6C4F)	✓ Similitud general
 TRASTORNOS INDUCIDOS POR SUSTANCIAS	Incluye trastornos mentales inducidos (psicosis, depresión, etc.)	También incluye trastornos inducidos por sustancias	✓ Alta similitud
 ADICCIONES COMPORTAMENTALES	Incluye juego patológico (y considera gaming como condición de estudio)	Incluye juego patológico y trastorno por videojuegos	✓ CIE-11 reconoce formalmente gaming
 APLICACIÓN CLÍNICA	Muy usado en EE. UU. e investigación	Uso global, sistema oficial de salud pública	✓ Diferencia en alcance y uso

SIMILITUDES CLAVE

Ambos sistemas reconocen que la adicción implica pérdida de control, deterioro funcional y cambios neurobiológicos, e incluyen intoxicación, abstinencia y trastornos inducidos.

DIFERENCIAS CLAVE

- El DSM-5-TR es más estructurado y cuantificable (ideal para investigación y evaluación estandarizada).
- El CIE-11 es más flexible y clínico, útil en contextos de salud pública y diversidad cultural.
- El CIE mantiene conceptos como uso nocivo y dependencia, mientras que el DSM integra todo en un solo continuo.



Impacto neurobiológico de los trastornos por consumo de sustancias y su relación con la excitotoxicidad cerebral



PAÍS Y AÑO

México (Guadalajara), 2026



AUTORES

Rafael de Jesús Macías Vélez
Andrea Reyes Rivera
Martha Catalina Rivera Cervantes
Jorge Peregrina Sandoval



TIPO DE INVESTIGACIÓN

Revisión teórica – bibliográfica
(alcance explicativo)



OBJETIVO

Analizar el papel de la neurotransmisión glutamatergica y la excitotoxicidad en los trastornos por consumo de sustancias.



BASE TEÓRICA CLAVE

La adicción es una enfermedad cerebral crónica caracterizada por:

- Compulsión
- Pérdida de control
- Estados emocionales negativos en abstinencia

La excitotoxicidad:

- Se produce por exceso de glutamato
- Genera daño neuronal y muerte celular
- Afecta la plasticidad sináptica



PALABRAS CLAVE

Glutamato – Dopamina – Excitotoxicidad – Adicción – Neurotoxicidad



REFERENCIA

De Jesús, R. Reyes, A. Rivera, M. Peregrina, J. (2026). Trastornos cerebrales por consumo de sustancias adictivas y su asociación con la excitotoxicidad. e-CUCBA, año 13 número 22, (ISSN 2448 – 5225). 8, 15. <http://e-cucba.cucba.udg.mx/index.php/e-Cucba/article/view/409/401>

VARIABLES



INDEPENDIENTES

- Consumo de sustancias adictivas
- Exposición crónica a drogas
- Alteración del sistema glutamatergico



DEPENDIENTES

- Daño neuronal
- Deterioro cognitivo
- Conducta compulsiva
- Disminución del control ejecutivo

ÁREAS CEREBRALES IMPLICADAS



- Sistema dopaminérgico mesolímbico
- Corteza prefrontal
- Hipocampo
- Amígdala
- Ganglios basales
- Cerebelo

MECANISMO PRINCIPAL (EXCITOTOXICIDAD)



ETAPAS DE LA ADICCIÓN

1. Compulsión al consumo
2. Pérdida de control (intoxicación/atracón)
3. Abstinencia (estado emocional negativo)

INTERACCIÓN CLAVE GLUTAMATO – DOPAMINA



Interacción bidireccional en la vía mesolímbica (área tegmental ventral, núcleo accumbens y corteza prefrontal) que modula recompensa, motivación y refuerza los trastornos adictivos.

INSTRUMENTOS (EN LA REVISIÓN)



Bases de datos científicas:

- Scopus
- PubMed
- Web of Science
- Scielo



Revisión de literatura (2016–2025)

RESULTADOS PRINCIPALES



Alteración de la comunicación neuronal



Deterioro en memoria, aprendizaje y toma de decisiones



Incremento de hábitos compulsivos



Mayor vulnerabilidad a recaídas

CONCLUSIONES



La excitotoxicidad es un mecanismo central en la adicción



La interacción glutamato–dopamina mantiene el trastorno



El daño cerebral dificulta la recuperación



Es clave para futuras intervenciones clínicas



FAMOSO RELACIONADO AL TEMA

Amy Winehouse:

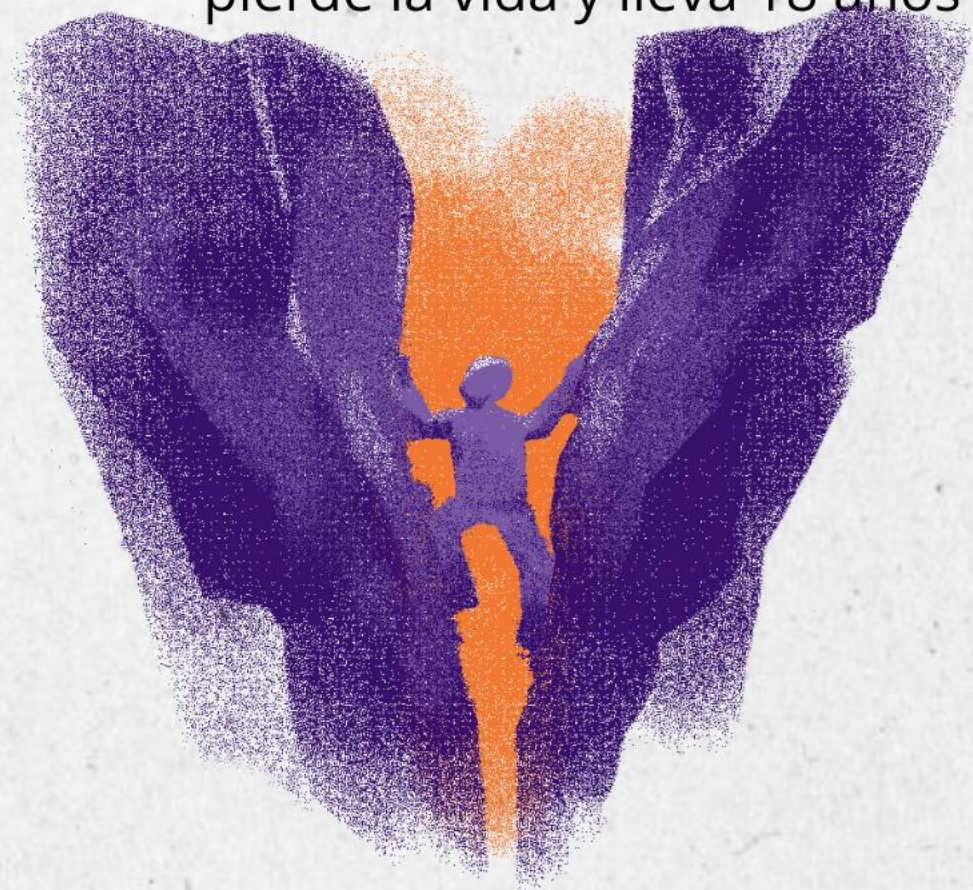
- Diagnóstico: Trastorno por consumo de alcohol
- Causa de muerte: intoxicación alcohólica



FAMOSO RELACIONADO AL TEMA

Eminem:

- Diagnóstico: Trastorno por consumo de opioides y sedantes
- Tuvo una sobredosis en el 2007 donde casi pierde la vida y lleva 18 años de sobriedad



FUENTES

Organización Panamericana de la Salud. (14 enero 2026). Trastornos por consumo de drogas, una creciente preocupación de salud pública en las Américas. OPS Organización Panamericana de la Salud. <https://www.paho.org/es/noticias/14-1-2026-trastornos-por-consumo-drogas-creciente-preocupacion-salud-publica-americas>

De Jesús, R. Reyes, A. Rivera, M. Peregrina, J. (2026). Trastornos cerebrales por consumo de sustancias adictivas y su asociación con la excitotoxicidad. e-CUCBA, año 13 número 22, (ISSN 2448 – 5225). 8, 15. <http://e-cucba.cucba.udg.mx/index.php/e-Cucba/article/view/409/401>

Hartney, M. (14 de octubre de 2025). Criterios del DSM 5 para los trastornos por consumo de sustancias. Beryweel Mind. <https://www.verywellmind.com/dsm-5-criteria-for-substance-use-disorders-21926>

Procuraduría General de la Nación. (14 de diciembre 2017). Informe de CONAPRED para el Control del Abuso de Drogas en Panamá y sus Eventos Conexos. PGN Procuraduría General De La Nación. <https://ministeriopublico.gob.pa/notas-de-prensa/informe-conapred-control-del-abuso-drogas-panama-evento-conexos/>



¡MUCHAS
GRACIAS!

